

บทคัดย่อ

ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเป็นความเสี่ยงสำคัญในระบบบริการสุขภาพ จากข้อมูลปีงบประมาณ 2568 ของห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก พบรายงานความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (Dispensing Error) ระดับ C ขึ้นไป จำนวน 6 ครั้ง และมีกรณีร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis) ด้วยผังก้างปลา (Fishbone Diagram) พบว่ากระบวนการบันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนก่อนจ่ายยา (Pre-dispensing Error) ยังขาดระบบติดตามที่รวบรวมอย่างเป็นรูปธรรม การบันทึกต่ำกว่าความเป็นจริง และเกิดจากปัจจัยหลากหลาย ได้แก่ การจัดเก็บยาที่คล้ายคลึงกัน (Look Alike Sound Alike: LASA) ยาที่มีหลายความแรง ขาดการตรวจสอบซ้ำ (Double Check) รวมถึงความเหนื่อยล้าและภาระงานที่หนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Time)

การศึกษานี้ดำเนินโครงการตามวงจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นเพื่อลดอัตราความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Patient Safety Culture) ภายในหน่วยงานโดยขับเคลื่อนผ่านมาตรการ 4 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาระบบรายงานและการสื่อสาร การปรับปรุงระบบงานและสิ่งแวดล้อม (Visual Control) การบริหารกำลังคน และการปรับปรุงสร้างมาตรฐาน (SOP)

ผลการศึกษา เปรียบเทียบข้อมูลก่อนพัฒนา (ธ.ค. 68 – ก.พ. 69; 40,574 ใบสั่งยา) และหลังพัฒนา (มี.ค. – พ.ค. 69; 41,127 ใบสั่งยา) พบว่า อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนก่อนจ่ายยาลดลงจาก 5.45 ครั้ง เหลือ 3.62 ครั้ง ต่อ 1,000 ใบสั่งยา คิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 33.6 ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมาย และไม่พบรายงานความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (Dispensing Error) ระดับ C ขึ้นไป รวมทั้งระบบบันทึกและรายงานความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาพร้อมรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา นำไปปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 โดยมีการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบจัดยา เพื่อทบทวนซ้ำก่อนส่งเภสัชกรตรวจสอบเพิ่มในคู่มือการปฏิบัติงาน PHA-QP-012 แนวทางการปฏิบัติในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก จากการศึกษานี้มีอัตราความคลาดเคลื่อนลดลงร้อยละ 33.6 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 20) แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารข้อมูลทันที การปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความผิดพลาดจากความคุ้นชิน และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ไม่มุ่งโทษบุคคล จะช่วยยกระดับกระบวนการทำงานให้เกิดผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ (Keywords): ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Errors), ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา (Pre-dispensing errors), วัฒนธรรมความปลอดภัย (Patient Safety Culture)